

TEMA 5.8 • HEMATOLOGÍA

Anemia en Insuficiencia Renal Crónica

PERFIL EUNACOM 1.07.1.008

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Anemia en Insuficiencia Renal Crónica

Causas (multifactorial)

- ↓ **Eritropoyetina** (EPO) → el riñón dañado produce menos
- ↓ aprovechamiento del hierro (puede haber ferropenia con **perfil de hierro** "normal")
- ↓ Vida media de los glóbulos rojos

Objetivos de tratamiento

TABLA 5.8.1: PARÁMETRO VS OBJETIVO	
PARÁMETRO	OBJETIVO
Hemoglobina	10 – 11,5 g/dL (no más alto)
Hierro (paso 1): ferritina + saturación	Ferritina > 100 + saturación > 20%

EUNACOM CRITERIOS

Orden estricto: primero corregir el hierro, luego la hemoglobina. Si se da EPO sin hierro → respuesta insuficiente.

Corrección del hierro

- **Siempre hierro EV** si está en diálisis
- Hierro oral solo si: no está en diálisis + saturación > 12% + Hb > 7
- **Meta de hierro** (cualquiera de estas):
- Ferritina > 400 ng/mL, o
- Saturación > 30%, o
- Ferritina > 100 + saturación > 20%

Corrección de la hemoglobina

- Una vez el hierro está en meta → **Eritropoyetina SC** (o análogos: epoetina, darbopoetina)

Casos clínicos tipo

TABLA 5.8.2: CASO VS HB				
CASO	HB	FERRITINA	SATURACIÓN	CONDUCTA
En diálisis	8,3	250	25%	Hierro OK → dar EPO
En diálisis	11	320	22%	Todo OK → no hacer nada
En diálisis	< 10	< 100	< 20%	→ dar hierro EV primero
IRC sin diálisis (CICr 30)	10	120	23%	Todo OK → no hacer nada

| IRC sin diálisis (CICr 45) | < 10 | < 100 | < 20% | → hierro oral (acepta EV igual) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente en hemodiálisis con hemoglobina de 8,5 g/dL, ferritina de 80 ng/mL y saturación de transferrina de 15%. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Anemia en Insuficiencia Renal Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La anemia en IRC es multifactorial: caída de eritropoyetina, disminución del aprovechamiento del hierro y menor vida media de los GR
- Orden estricto: PRIMERO corregir el hierro, SEGUNDO manejar la hemoglobina
- El hierro suele ser endovenoso en IRC; el oral no sirve en la mayoría de los casos
- Objetivos de hierro: ferritina >400, O saturación >30%, O ferritina >100 + saturación >20%
- Objetivo de hemoglobina: entre 10 y 11,5 g/dL con eritropoyetina SC o análogos
- Hierro oral solo si: no está en diálisis + saturación >12% + hemoglobina >7
- El error más frecuente es intentar dar tratamiento cuando el paciente cumple ambos objetivos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA EN INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA)**PREGUNTA 1**

Paciente en hemodiálisis con hemoglobina de 8,5 g/dL, ferritina de 80 ng/mL y saturación de transferrina de 15%. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A)** Iniciar eritropoyetina subcutánea
- B)** Transfundir concentrado de glóbulos rojos
- C)** Hierro endovenoso
- D)** Hierro oral
- E)** Observar y controlar en 1 mes

PREGUNTA 2

Paciente con IRC en hemodiálisis, hemoglobina de 10,5 g/dL, ferritina de 250 ng/mL y saturación de transferrina de 25%. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Iniciar eritropoyetina subcutánea
- B)** Hierro endovenoso
- C)** No requiere tratamiento actualmente
- D)** Hierro oral
- E)** Transfusión de glóbulos rojos

PREGUNTA 3

¿Cuál es el objetivo de hemoglobina en el manejo de la anemia por insuficiencia renal crónica?

- A)** Hemoglobina >12 g/dL
- B)** Hemoglobina >13 g/dL
- C)** Hemoglobina entre 10 y 11,5 g/dL
- D)** Hemoglobina >7 g/dL
- E)** Hemoglobina >14 g/dL

RESUMEN: ANEMIA EN INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Esta clase aborda el manejo de la anemia en insuficiencia renal crónica, cuya causa es multifactorial: caída de la eritropoyetina, disminución del aprovechamiento del hierro y caída de la vida media de los glóbulos rojos. El tratamiento sigue un orden estricto: primero corregir el hierro (endovenoso en la mayoría de los casos) y luego manejar la hemoglobina con eritropoyetina subcutánea o análogos. El objetivo de hemoglobina es entre 10 y 11,5 g/dL. Los objetivos de hierro se cumplen con cualquiera de tres criterios: ferritina >400, saturación de transferrina >30%, o ferritina >100 + saturación >20% (el más frecuentemente logrado). El hierro oral solo se considera si no está en diálisis, saturación >12% y hemoglobina >7. Se presentan cinco casos clínicos que ilustran la aplicación de estos criterios, enfatizando que el error más frecuente es intentar dar tratamiento cuando no se necesita.